

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Esteban Alejandro Paillalef Echeverría	Rut	: 17.543.362-7	N° Archivo : 0731298
Edad	: 34a 6m 5d	Fecha Nacto:	22/03/1990	Sexo : Masculino
Dirección	: Minero Godoy 866 El Tranque	Comuna	: Puente Alto	Teléfono : 9 6406 6780

Información Hospitalización				Días Estadía: 12
Unidad de Ingreso	: Utim (5to Piso Mater)	Fecha Ingreso	: 15/09/2024 16:43	
Unidad de Egreso	: Utim (5to Piso Mater)	Fecha Egreso	: 27/09/2024 18:09	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
Compromiso de Conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico
FI CASR: 15/09/24.

ANTECEDENTES

- Antecedentes Médicos: PPVI en TARV (parcial adherencia) (CV en 57800 y CD4 en 552 cels del 16/5/2024), Sífilis 2023 (condilomas rectales), Sífilis latente precoz (condiloma oral), ERC-HD (Tunelizado, M-J-S, Cordial) (abandonado hace 1 mes), Enfermedad de Crohn, Trastorno depresivo.
- Antecedentes Quirúrgicos: Peritonitis apendicular, Maxilofacial?
- Fármacos: TARV (Prezcobix - Dolutegravir), Mesalazina, Acetato de Calcio.
- Alergias: No refiere.
- Hábitos: TBQ activo (IPA 2.7 paq/año), OH ocasional, Drogas (-).
- Hospitalizaciones Recientes: Julio 2024 por AKI sobre ERC, Mayo 2024 por NAC ATS III.

HISTORIA ACTUAL

Encontrado por vecinos a las 14:30 hrs. del 15/09 con aparente compromiso de conciencia, después de escuchar gritos. Última vez bien visto, el día previo a las 20 hrs del 14/09. Ingres a con HDN estable, normocárdico (91 lpm), hipertenso (146/63/90 mmHg), afebril (36.0°C), con buena mecánica ventilatoria, sin O2 adicional, logrando SpO2 99%. De lo neurológico ingresa en estado de vigilia, inatento, disártrico, con tendencia a desviar mirada a la derecha, con hemianopsia izquierda por amenaza, PFC izquierda, negligencia a izquierda y plejía FBC izquierda. NIHSS: 17 pto. Laboratorios destaca PCR en alza, con leucocitosis, bicitopenia (GR + PLQ), hiponatremia moderada, hipokalemia leve, acidosis metabólica parcialmente compensada con AG elevado, BUN al alza y transaminasas alteradas (patrón colestásico). Microbiología (15/09) con HMC 1 y 2 (+) CGP en racimo a las 6.55 y 6.56 hrs.

EXÁMENES DE INGRESO

- 15/09 TC + angioTC: Infarto frontoparietal derecho territorio de ACM derecha, sin oclusión de grandes vasos. No se aprecia ateromatosis IC.
- 15/09 TAC TAP: Opacidades pulmonares peribroncovasculares con densidad en "vidrio esmerilado" en la base pulmonar derecha, Obs. inflamatorio infeccioso. Leve esplenomegalia homogénea, asociado un área hipodensa puntiforme subcapsular sugerente de una pequeña área de infarto. Adenopatía hiliar derecha asociada a linfonodos prominentes iliacos externos bilaterales de aspecto inespecífico. Leve engrosamiento parietal circunferencial rectal de aspecto inespecífico, asociado a pequeñas adenopatías meso rectales de aspecto indeterminado. Catéter venoso central yugular interno izquierdo con extremo

Fecha Última Actualización: 27-09-2024 18:06:46

Página 2 de 3

distal en aurícula derecha, asociada a pequeña colección hipodensa organizada en relación a su ingreso subcutáneo.

Impresiona ACV consolidado, sin oclusión de grandes vasos, sin ateromatosis intracraneal, por lo que se sospecha origen embólico asociado a bacteriemia por CGP en racimo. Se desestima terapia de reperfusión. Evoluciona con sopor superficial.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Compromiso de conciencia multifactorial.
2. ACV Isquémico frontoparietal de ACD derecha: Consolidado.
 - Sin oclusión de grandes vasos | Sin ateromatosis intracraneal.
 - Posible mecanismo embólico.
3. Sepsis multifocal en estudio:
 - Bacteriemia por CGP en racimo.
 - NAC ATS III LID.
 - Infarto esplénico (con esplenomegalia).
 - Obs. EBSA.
4. AKI sobre ERC V:
 - BUN al alza, Hiponatremia moderada, Hipokalemia leve.
 - Acidosis metabólica parcialmente compensada con AG elevado.
5. Transaminasas alteradas (patrón colestásico).
6. Bicitopenia en estudio.
7. Desnutrición calórica proteica.
8. Antecedentes.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS

1. Hemodinamia: Shock séptico versus hemorrágico resuelto.
2. Respiratorio: IRA parcial por shock resuelto, suspende CNAF, con buena tolerancia a naricera. Mantuvo KNT R.
3. Infeccioso:
 - VIH: TARV con mala adherencia, últimos exámenes: CV 57.800 y CD4 552 (abril 2023: LDL). Actualmente con CV 648 y CD4 530 (24 de septiembre, 2024). Reinicia TARV el 17/09 con DTG + DRVc. Se envía toma de CD4 y CV (pendiente rescatar). VDRL sin indicación de tratamiento dirigido.
 - Coinfecciones: VHB/VHC NR, Chagas NR, GeneXpert (-), BK (-), VDRL reactivo sin diluir, MHA-TP reactivo, IgG/IgM Toxoplasma (-), IgG CMV (+), IgM CMV (-), IgG VEB (+), IgM VEB (-), cul tivo TBC (p).
 - Otros: ITS CVC por SAMS (HCq periférico y arrastre CVC ambos con >100UFC), con embolías sépticas: ACV, infarto esplénico, NAC, además con colección en trayecto CHD YI° (retirado 18/09). (p) ETT y FO. Altamente sugerente de endocarditis infecciosa. HC de control 19/09 negativos. Se mantiene cefazolina en dosis altas. Cursó con episodios diarreicos, con Toxina AB (-), coprocultivo (p).
- Desde 25/09 con descompensación hemodinámica y ventilatoria, interpretado como sobreinfección vs nueva embolia séptica.
4. Neurológico: ACV isquémico frontoparietal de ACD derecha, obs embólico, ya consolidado. Mantiene medidas de neuroprotección. El 27/09 cursó con nuevo episodio de focalidad y compromiso de conciencia, sospecha de nueva embolia séptica con ACV
5. Medio Interno / Nefrológico: ERC-V en HD (mala adherencia). CHD transitorio femoral derecho.
6. Hepático: En seguimiento por transaminasas alteradas, patrón colestásico, sin signos obstructivos al TC. Cuenta con VHB/VHC NR. Mantener seguimiento.
7. Nutricional: Desnutrición CP severa, en seguimiento y ajuste por ANI. Control de parámetros nutricionales.
8. Rehabilitación: Mantiene SNG. Pendiente evaluación por FNA. Según evolución considerar Fisiatría/TO.
9. Profilaxis: Mantiene medidas de gastroprotección con IBP. Sin tromboprofilaxis ACV y hematoma recientes.

El 27/09 evolucionó con compromiso de conciencia, objetivando estado de coma, con midriasis arrefléctica y desviación de la mirada a izq, en gasping y bradicárdico hasta 30 lpm.

Sin respuesta a estímulo doloroso, impresiona ACV en curso.
Dada AET no se realiza reanimación.

Se llama a familiares y finalmente se constata fallecimiento a las 16:22.

Diagnósticos en Certificado:

Fecha Epicrisis : 27/09/2024 18:06

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 27-09-2024 18:06:46

Página 3 de 3

- Accidente Cerebrovascular
 - Embolia Séptica
 - Endocarditis Infecciosa
- Concomitantes: ERC en diálisis, Infección por VIH

Diagnóstico de Egreso

Endocarditis infecciosa -
Accidente vascular isquémico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

--

Plan Post Alta

--

Indicaciones

Tipo de Reposo :

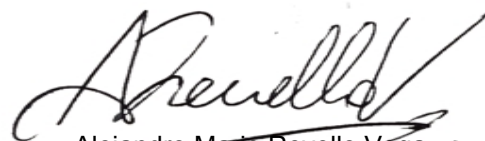
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Alejandro Mario Revello Vega

Médico Tratante (Staff)